13. STRUKTURIERUNG DES GEFÄßSYSTEMS : NOTIZEN

DAUER : 03:24 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir die Strukturierung des Gefäßsystems während der Embryonalentwicklung, wobei der Schwerpunkt auf der Verbindung zwischen dem Dottersack und der Amnionhöhle liegt. Die Konzepte der Kephalisation, Kardialisierung und Diaphragmatisierung werden detailliert beschrieben und veranschaulichen, wie sich das Gefäßsystem im Laufe seiner Entwicklung zentralisiert. Durch die Analyse der Kardinalsysteme und der Bildung der venösen Gefäßachse werden wir entdecken, wie Flüssigkeitsbewegungen und seitliche Keimungen zur Bildung einer „Schutzaura“ beitragen, die für die Entwicklung des zerebralen Systems unerlässlich ist. Dieser Ansatz unterstreicht die Bedeutung der Reintegration von Zone B bei der Behandlung des Nervensystems und stellt eine entscheidende Verbindung zwischen dem Nabel und den embryonalen Strukturen her.

STRUKTURIERUNG DES GEFÄßSYSTEMS

Das **Gefäßsystem**, das sich an der Peripherie entwickelt, ist tief in die **Dottersackblase** integriert. Die **Wolff-Pander-Inseln** zum Beispiel bilden sich in der Verdopplung dieser Blase.

Hinter der Dottersackblase befindet sich die **Amnionhöhle**. Stellen Sie sie sich wie einen **Luftballon** vor, der dieses Kreislaufsystem enthält, das sich auch in der Achse befindet.

Dieser "Ballon" wird sich entleeren, und das gesamte periphere System wird sich zentralisieren. Diese Zentralisierung wird von der Amnionhöhle orchestriert.

Ihre differentielle Wachstumsgeschwindigkeit, im Vergleich zum **primitiven Gefäßfeld** und der Entwicklung des **Gehirns**, erzeugt eine Sogbewegung. Äußerlich wird dies von einem **transversalen Schub** begleitet, sowohl thorakal als auch abdominal.

Die Längsachse ist komplexer und integriert die **Kephalisation**, die **Kardialisierung**, die **Diaphragmatisierung** und das gesamte **hintere Peritoneum** bis zum **Perineum**.

Dieser Prozess ist vergleichbar mit dem sich integrierenden Ballon. Gleichzeitig gibt es an der Peripherie eine enorme Bewegung, die zum **Nabelstrang** konvergiert. Der Nabelstrang ist, wie wir uns erinnern, der Treffpunkt zwischen dem **Embryonalstiel** und der Dottersackblase, wobei letztere sich allmählich zurückbildet.

Das Geheimnis hier ist die **embryonalen Bewegung** und die **Motilität der Entwicklung**: die Flüssigkeiten immer zur Mitte zu führen.

Wir werden die **Kardinalsysteme** (Subkardinal- und Supra-Kardinalsystem) detailliert untersuchen, um schließlich zu einer **venösen Gefäßachse** zu gelangen. Letztere weist spezifische Überreste auf.

Das venöse Gefäßsystem entwickelt sich **transversal** und nicht longitudinal. Es besteht aus Teilen, die aus verschiedenen Richtungen stammen und das Ergebnis einer transversalen Vereinigung sind.

Dies steht im Gegensatz zum arteriellen Gefäßsystem, das **longitudinal** mit zwei großen Leitungen funktioniert. Auf der venösen Ebene handelt es sich um **laterale Keimungen**, d.h. neue Verläufe.

Wenn sich die Flüssigkeiten zur Mitte hin integrieren, öffnet und zeichnet sich die **Zone B** ab und bildet eine Art **Schutzaura**. Diese Blase trägt unter anderem zum Aufbau des **Gehirnsystems** bei.

Die erste Höhle, die erscheint, oder vielmehr die zweite, ist die Amnionhöhle. Zu diesem Zeitpunkt wird der **Embryonalknoten** zum zukünftigen **Epiblasten**, dem zukünftigen Nervengewebe.

Die beiden dürfen nicht getrennt werden. Wenn wir das Nervensystem behandeln wollen, müssen wir die Zone B immer wieder integrieren. Dies konvergiert auf die gesamte **Medianachse** und schließlich auf die **Nabelregion**.

Der **Nabel** ist der endgültige Treffpunkt, die Verbindung zwischen dem Embryonalstiel und der Dottersackblase.